

ОСНОВИ НА КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ТЕРАПИЯ (КПТ)

Академична учебна програма за студенти по психология • Пълен 15-седмичен курс

Академичен съвет: Катедра по Клинична психология

Продължителност: 15 седмици (1 семестър)

Основоположници: По модела на д-р А. Бек и д-р Дж. Бек

Кредити: 6 ECTS (Теоретико-практически)

Тази програма предоставя систематичен учебен план, обхващащ историческия път, фундаменталните теории, клиничните методи и емпиричната валидация на Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ). Курсът превежда студентите през еволюцията на модела на д-р Аарон Бек — от ранните му изследвания в психоанализата до модерните терапевтични техники и иновативната Възстановително-ориентирана когнитивна терапия (СТ-R). Програмата е балансирана между солидни теоретични основи и усвояване на практически умения за концептуализация, поведенческа активация и когнитивно реструктуриране.

ОБЗОР НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ МОДУЛИ

Модул	Тематичен обхват	Седмици	Основни фокусни точки
Модул I	Теоретични и исторически основи на когнитивния модел	1 - 3	Преход от психоанализа; сравнение с REBT (Елис); структура на вярванията; депресивна триада на Бек.
Модул II	Клинична оценка, терапевтичен съюз и първи стъпки	4 - 7	Когнитивна концептуализация; BDI/BAI скали; терапевтичен съюз; протокол на сесия 1; поведенческа активация.
Модул III	Практически когнитивни интервенции и реструктуриране	8 - 12	Автоматични мисли; когнитивни изкривявания; сократически въпроси; Дневник на мислите; Междинни/Основни вярвания.
Модул IV	Специфични техники, превенция на рецидив и нови хоризонти	13 - 15	Вземане на решения; кругови диаграми; планиране на излагане; превенция на рецидиви; СТ-R за тежки състояния.

МОДУЛ I: ТЕОРЕТИЧНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОГНИТИВНИЯ МОДЕЛ

Седмица 1: Въведение в когнитивната терапия: Научният преход от психоанализа

Анализ на раждането на Когнитивната терапия в началото на 60-те години от д-р Аарон Т. Бек. Разглеждане на неговия преход от психоаналитично обучение към емпирично тестване на аналитичните конструкции за депресията (например хипотезата за депресията като агресия, обърната навътре или 'ретрофлексизирана враждебност'). Осъзнаване на провала на експериментите да потвърдят този модел, което води до преформулиране на депресията от афективно в когнитивно разстройство.

- Интелектуалният прелом: депресията като състояние на систематична когнитивна дисфункция.
- Идентифициране на 'автоматичните мисли' (NAT) — спонтанни, бързи, лишени от обективна валидност.
- Значението на съставянето на структурирани терапевтични протоколи и наръчници за изследване на ефикасността.
- Основополагащият труд 'Cognitive Therapy for Depression' (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) и пионерният модел на 'емпирично валидирано лечение'.

Седмица 2: Парадигмален паралел: Когнитивната терапия на Бек срещу REBT на Елис

Подробно изследване на философията и на тестването на предположения между двете водещи когнитивни школи — Когнитивната терапия (КТ) на Бек и Рационално-емоционалната поведенческа терапия (REBT) на Алберт Елис. Анализ на усещането за страдание и емоционална дисфункция.

- Разлика при тестването на предположения: в REBT предположенията на клиента се приемат за верни в началото, за да се разкрият ирационалните убеждения; в КТ те се тестват за валидност чрез колаборативен емпиризъм.
- Трите абсолютни и силно ирационални изисквания ('musts') в REBT и ролята им в поддържането на невротичното страдание.
- Философията за Безусловно самоприемане (USA) срещу самооценяването ('self-rating trap') и неговото преодоляване.
- Разграничаване на абсолютистките изисквания на Елис от когнитивните изкривявания (когнитивни грешки) на Бек.

Седмица 3: Архитектура на Когнитивния модел: Йерархия на мисленето, Триада и Двойна обработка

Изучаване на йерархичната структура на когнициите: Автоматични мисли (повърхностни, ситуативни), Междинни вярвания (нагласи, правила, предположения) и Схеми / Основни вярвания (дълбоки, глобални структури). Изследване на когнитивния модел за депресията и преработката на данни.

- Когнитивната триада на депресията по Бек: ирационален, негативен възглед за Себе си, Света и Бъдещето.
- Механизъм на Когнитивната схема: как негативните схеми действат като екран/филтър, пропускащ само потвърждаващи данни (правоъгълници), и отхвърлящ положителните факти (триъгълници) като 'случайни изключения'.
- Модел за двойна обработка на информация: автоматична (heuristic, бърза, vulnerable) и рефлексивна (reflective/secondary) обработка на данни.

- Ролята на селективния/автоматизирания фокус на вниманието върху детайлите от контекста и неговото значение за поведението.

КЛИНИЧНА БЕЛЕЖКА: ЕФЕКТЪТ НА СХЕМАТА

Когнитивната схема не е просто абстрактно понятие; тя функционира като интелектуален 'екран'. Когато пациентът е в депресивно състояние, когнициите се изкривяват автоматично. Пациентът филтрира всички доказателства за собствената си компетентност чрез твърдението 'Да, но...'; превръщайки положителния опит в потвърждение на негативното си вярване ('Аз съм некомпетентен').

МОДУЛ II: КЛИНИЧНА ОЦЕНКА, ТЕРАПЕВТИЧЕН СЪЮЗ И ПЪРВИ СЪПКИ

Седмица 4: Диагностична сесия и изготвяне на Когнитивна концептуализация

Методология на първоначалното диагностично интервю и оценка на състоянието на пациента. Обучение в събирането на анамнеза, оценка на суицидният риск и прилагането на стандартизирани клинични формуляри (Инвентар за депресия на Бек - BDI, Инвентар за тревожност - BAI, Скала за безнадеждност - BHS).

- Изготвяне на Когнитивна концептуализация на базата на клиничния случай (Cognitive Conceptualization Diagram по Дж. Бек).
- Свързване на ранните детски преживявания и критични съобщения с формирането на отрицателни ядра.
- Идентифициране на компенсаторни (стратегии за справяне) поведения за предпазване от активиране на основните вярвания.
- Модел на уязвимостта (диатеза-стрес): кога специфични житейски стресори отключват депресивната уязвимост.

Седмица 5: Принципи на КПТ и изграждане на Терапевтичния съюз

Запознаване с 10-те фундаментални принципа на Когнитивната терапия. Фокус върху изграждането на безопасен, емпатичен и стабилен терапевтичен съюз. Овладяване на баланса между структурираност и гъвкавост в сесията.

- Колаборативен емпиризъм: терапевтът и клиентът като научни сътрудници, изследващи реалността.
- Ролята на редовната обратна връзка в края на сесията за превенция на преждевременно прекратяване.
- Идентифициране и терапевтично отговаряне на дисфункционалните вярвания на пациента за терапията и терапевта.
- Поведение на терапевта: как да се извиним съвместно и да коригираме прекалено контролирания или изищна съюз, когато сме били натрапчиви.

Седмица 6: Протокол и структура на терапевтичната сесия (Първа сесия срещу Сесия 2+)

Детайлно изучаване на структурата на терапевтичната сесия в КПТ. Овладяване на времевото разпределение и стъпките за Първата сесия и за следващите сесии. Социализиране на пациента в КТ структурата.

- 10-те стъпки на Първата сесия (дневен ред, проверка на настроението, актуализация, диагностика, психообразование, цели, образование за модела, обсъждане на проблем, домашно, обратна връзка).

- Структура на Сесия 2+: бързо и точно съвместно определяне на дневен ред в началото, преглед на домашното.
- Техники за преодоляване на съпротива и затруднения при задаване на дневен ред (пациенти, които не допринасят, бърборят или са безнадеждни).
- Моделиране на нежно и тактично прекъсване на пациента за структуриране на фокуса на разговор.

Седмица 7: Поведенческа активация (Behavioral Activation): Преодоляване на апатията

Концептуализация на депресивната неактивност и нейния порочен кръг (първи и втори затворен кръг на депресията). Овладяване на поведенческия принцип: как действията влияят върху мислите и емоциите. Изготвяне на планове за действие.

- Изготвяне и проследяване на ежедневен Activity Monitoring Chart (График на активността).
- Оценка на настроението по скала от 0 до 10 съвместно с извършваните активности за откриване на модели.
- Разграничаване и измерване на субективните скали за Pleasure (Удоволствие) и Mastery (Майсторство/Овладяване).
- Метод на Pleasure Predicting (прогнозиране на удоволствието) за изобличаване на негативните депресивни очаквания.

МОДУЛ III: ПРАКТИЧЕСКИ КОГНИТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

Седмица 8: Улавяне на Автоматичните мисли и емоциите

Овладяване на първата стъпка от когнитивното реструктуриране: прецизното идентифициране на ситуативните автоматични мисли (NATs). Разграничаване на мисли от емоции. Изследване на когнициите в сесията.

- Разграничаване на интерпретациите от обективните факти (емоциите се описват с една дума, мислите са твърдения).
- Изучаване на трите типа автоматични мисли: изкривени, точни с изкривено заключение, точни но дисфункционални.
- Техники за ярко образно припомняне (въображение) и ролеви игри за извличане на 'горещи когниции' в сесия.
- Детекция на несъответствия между съдържанието на автоматичната мисъл и емоцията (напр. тревожна мисъл, водеща до тъга).

Седмица 9: Каталог на Когнитивните изкривявания и Дневник на мислите

Детайлно проучване на когнитивните пристрастия и логически грешки в мисленето по Бек и Бърнс. Обучение на студентите в практическото приложение на Дневника на дисфункционалните мисли (Thought Record) като основен инструмент.

- Изкривявания: черно-бяло мислене, катастрофизирание, произволно заключение, ментален филтър (селективна абстракция), омаловажаване на позитивното, емоционално мислене, етикетиране, персонализация, 'трябва'-твърдения.
- Структура на Thought Record 'Plus': ситуация, емоция (0-100), автоматична мисъл, изкривяване, доказателства 'за' и 'против'.
- Формулиране на балансиран (рационален) отговор въз основа на обективните факти, без самоизмама.
- Преоценка на емоциите и последващото поведение след прилагане на писменото реструктуриране.

Седмица 10: Колаборативно изследване на реалността: Сократически въпроси

Овладяване на Сократическия диалог (Socratic Questioning) като основен метод за когнитивно реструктуриране. Разработване на умения за водене на безпристрастно изследване на мислите на пациента.

- Въпроси за обективни доказателства: 'Какви са фактите, които подкрепят мисълта? Какви са фактите против нея?'
- Търсене на алтернативни гледни точки: 'Има ли друго обяснение за случилото се, освен това, което мислиш?'
- Декатастрофизирание: 'Кое е най-лошото, най-доброто и най-реалистичното резултати? Как би се справил?'
- Оценка на последиците и Дистанциране: 'Какъв е ефектът от това да вярваш в мисълта? Какво би казал на приятел в същата ситуация?'

Седмица 11: Реструктуриране на средно ниво: Модифициране на Междинни вярвания

Идентифициране и промяна на междинните вярвания — нагласи, правила и условни предположения, които ръководят поведението на пациента и произтичат директно от дълбоките му схеми.

- Приложение на техниката 'Стрела надолу' (Downward Arrow Technique) за извличане на скритото вярване зад автоматичната мисъл.
- Изследване на предимствата и недостатъците от поддържането на дадено правило или условно вярване.
- Техника за преобразуване на ригидни правила ('Аз не трябва да искам помощ') в гъвкави предположения ('Ако поискам помощ, показвам сила').
- Оспорване на правилата чрез когнитивно несъответствие в специфични ситуации.

Седмица 12: Преструктуриране на дълбоко ниво: Работа с Основни вярвания (Схеми)

Методология за модифициране на най-дълбокото когнитивно ниво. Категоризиране на негативните схеми в трите основни области на уязвимост и прилагане на когнитивни и емоционални техники за промяна.

- Трите категории основни вярвания: Безпомощност (Incompetence/Weakness), Необичаемост (Unlovability) и Безстойностност (Worthlessness).
- Структура и приложение на Core Belief Record (Работен лист за основни вярвания) за ежедневно проследяване на контра-данни.
- Техника на Когнитивния континуум (Criteria Continua) за разбиване на черно-бялата оценка на Аз-а.
- Приложение на емоционално-опитни техники: исторически тест на схема, ролеви игри с по-младото и по-възрастното Аз.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПАДЕСКИ ЗА ПРОМЯНА НА СХЕМИ

При работа с хроники или дълбоки схеми (като 'Аз съм лош' или 'Аз съм некомпетентен'), контра-доказателствата често биват отблъснати от схемата. Затова Падески препоръчва активно да се идентифицира и изгради желана алтернативна схема в собствените думи на клиента ('Аз съм компетентен в много отношения, но съм само човек'). Работата по събиране на доказателства се фокусира изцяло върху новата схема, а не върху оспорване на старата.

МОДУЛ IV: СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЦИДИВ И НОВИ ХОРИЗОНТИ

Седмица 13: Вземане на решения, Поведенчески експерименти и Диаграми на отговорността

Усвояване на разширения поведенчески и графичен инструментариум на КПТ. Практическа работа за преодоляване на избягващото поведение, когнитивно структуриране на вината и вземане на решения.

- Изготвяне на табличен анализ на Предимствата и Недостатъците при вземане на решения с претегляне по скала от 1 до 10.
- Планиране и стъпково разбиване на поведенчески експерименти (излагане) за справяне с тревожното избягване (Exposure Hierarchy).
- Техниката 'Кругова диаграма' (Pie Chart) за графично преразпределение на отговорността за даден резултат (Responsibility Pie).
- Изграждане на Credit List (Списък с кредити/постижения) за преодоляване на селективното фокусиране върху депресивните неуспехи.

Седмица 14: Домашна работа, Прекратяване на терапията и Предотвратяване на рецидив

Проектиране на персонализирани, съвместно договорени домашни задачи. Преодоляване на терапевтичните бариери и подготовка на пациента за приключване на активната терапия и преминаване към самостоятелна поддръжка.

- Правилно структуриране на домашната работа: изискване на ясни детайли (как, кога, бариери, ресурси) за гарантиране на успех.
- Психообразование за хода на подобрението по скала (визуална графика): наличие на плата, нормални колебания и временен регрес.
- Обучение в провеждането на самостоятелни сесии за самотерапия (Self-Therapy Sessions) след края на терапевтичния курс.
- Разработване на План за действие при рецидив (Action Plan for Relapse) с конкретни стъпки и писмени терапевтични бележки.

Седмица 15: Разширение на КПТ: Третата вълна и Възстановително-ориентирана когнитивна терапия (СТ-R)

Запознаване на студентите с новите хоризонти в когнитивно-поведенческите науки. Анализ на фундаменталния преход от промяна на съдържанието на мислите към промяна на отношението към тях.

- Общ обзор на 'Третата вълна': АСТ (Терапия на приемане и ангажираност), DBT (Диалектическа поведенческа терапия), MBCT.
- Въведение във Възстановително-ориентираната когнитивна терапия (СТ-R) на Бек за работа с тежки психиатрични състояния.
- Методология на СТ-R: фокус върху ценностите, овластяването и активиране на Адаптивния режим (Adaptive Mode) пред симптомите.
- Използване на силните страни на клиента и преминаване от отстраняване на дефицитите към изграждане на пълноценен живот.

ПРЕДПИСАНА ЛИТЕРАТУРА И АКАДЕМИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ

- **Beck, J. S. (2011/2020).** *Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Second/Third Edition)*. Guilford Press. (Основен учебник за клинична практика и концептуализация).
- **Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979).** *Cognitive Therapy for Depression*. New York: Guilford Press. (Историческият и основополагащ труд за клиничните протоколи).
- **Padesky, C. A. (1994).** *Schema Change Processes in Cognitive Therapy*. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 1(5), 267-278. (Основна методология за модифициране на схеми и континууми).
- **Beck, A. T., & Haigh, E. A. (2014).** *Advances in Cognitive Theory: The Generic Cognitive Model*. *Annual Review of Clinical Psychology*, 10, 1-24. (Основа за двойното кодиране и селективния фокус на вниманието).
- **Ellis, A. (1956/2005).** *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)*. (Философски и теоретични различия, концепцията за USA и трите абсолютни изисквания).